

KRIZOVÉ SCÉNÁŘE

SITUACE OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

1. Tonutí

Tonutí je navzdory obecnému přesvědčení velmi tichý a klidný proces. Ve většině případů tonoucí nemává rukama a nekřičí o pomoc. Instruktoři musí po celou dobu výuky skenovat nejenom hladinu bazénu, ale i dno bazénu. Pohybem po kraji bazénu lze výrazně zefektivnit toto skenování (instruktor nikdy nestojí na jednom místě). Další nezbytností je neustálé počítání žáků.

První pomoc u tonutí

1. instruktor

První zasahující dá znamení druhému instruktorovi třemi dlouhými hvizdy na píšťalku. Následně vstupuje do vody tzv. skokem do neznámé vody vždy tak, aby měl neustále vizuální kontakt s tonoucím. Otáčí tonoucího do polohy na zádech obličejem z vody. Opatrně přesouvá tonoucího ke kraji bazénu. První zasahující podá druhému instruktorovi ruce tonoucího a následně vyleze na kraj bazénu. Pomocí tzv. přetočením vytáhne tonoucího z vody a položí na rovnou plochu na kraji bazénu. (v případě, že kraj bazénu není vyvýšen, může vyndat tonoucího bez

pomoci druhé osoby). První zasahující zkontroluje dýchání a informuje **2. instruktora**.

Tonoucí nedýchá=> resuscitaci zahajuje 5 úvodními vdechy, následně pokračuje 15 stlačením hrudníku a 2 vdechy, takto opakuje do příjezdu záchranné služby nebo nabití vědomí tonoucího.

Tonoucí dýchá=> tonoucího přetočíme do stabilizované polohy, přikryjeme ručníky a kontrolujeme dýchání a vědomí do příjezdu záchranné služby

2. instruktor

Ihned po zaznamenání třech dlouhých hvizdů dává povel všem žákům v bazénu, aby neprodleně opustili vodu. Žáky předává doprovodné osobě ze školy a zapojuje se do záchranné akce. V případě, že je potřeba, pomůže prvnímu zasahujícímu přemístit tonoucího z vody na rovnou plochu na kraji bazénu.

Tonoucí nedýchá=> Vytáčí číslo 155 a odpovídá stručně a věcně na otázky operátora. Mobilní telefon přepíná do funkce handsfree a v případě únavy prvního zasahujícího ho vystřídá a pokračuje 15 stlačením hrudníku a 2 vdechy, takto opakuje do příjezdu záchranné služby nebo nabití vědomí tonoucího.

Tonoucí dýchá=> tonoucího přikryjeme ručníky. Pokračuje v telefonátu se záchrannou službou a následuje jejich rad.

2. Poranění páteře ve vodě

Úrazy páteře s jejich následky jsou jedny z nejzávažnějších poranění. Vlivem špatného zacházení a manipulace při záchraně můžete postiženému ještě více uškodit. U stabilizace páteře nemá rychlost záchrany žádný pozitivní vliv – zde spíše platí, čím déle a pomaleji tím mnohdy lépe.

Vždy vycházíme z předpokládaného mechanismu úrazu, při kterém mohlo dojít k poranění páteře (většinou skok po hlavě do vody). Pokud máme sebemenší podezření, musíme jednak tak, abychom u postiženého eliminovali jakýkoli nežádoucí pohyb a dostatečně jej stabilizovali do příjezdu záchranné služby.

První zasahující se k tonoucímu přibližujeme co nejopatrněji, aby nevytvářel žádné větší vlny, které by jeho zranění mohly zhoršit.

Druhý zasahující ihned po zaznamenání třech dlouhých hvizdů dává povel všem žákům v bazénu, aby neprodleně opustili vodu. Žáky předává doprovodné osobě ze školy a zapojuje se do záchranné akce. Vytáčí 155, přepíná do módu handsfree a následuje rad operátora záchranné služby.

Po přiblížení k tonoucímu je nutné ihned ve vodě zjistit přítomnost vědomí a dýchání.

Pokud je tonoucí v poloze na břiše, musíme jej nejdříve šetrně otočit do polohy na zádech.

Pokud je tonoucí při vědomí nebo je v bezvědomí, ale dýchá normálně, ponecháme jej ve vodě a zahajujeme stabilizační techniky. Před tím nesmíme zapomenout zavolat záchrannou službu na tel. 155. Pokud je nás na místě více, určíme osobu, která odbornou pomoc zavolá a my se věnujeme záchraně.

Pokud je tonoucí v bezvědomí a nedýchá normálně nebo si zachránce není jistý, zda postižený dýchá normálně, je nutné jej ihned a jakkoli dopravit ke břehu, dostat jej na tvrdou podložku a okamžitě zahájit resuscitaci (zde má prioritu resuscitace před stabilizací páteře). Samozřejmě se vše snažíme provádět co možná nejšetrněji, ale ne na úkor rychlosti, která zde má prioritu.

Stabilizační techniky

Stabilizační techniky aplikujeme pouze u tonoucích, kteří jsou 1/ při vědomí nebo 2/ v bezvědomí s normálním dýcháním. Stabilizační techniky používáme pouze v mělkých vodách. Pokud dojde ke zranění na hluboké vodě je nutné nejprve tonoucího dopravit na mělkou vodu a tam teprve zahájit stabilizaci páteře. Stabilizace na hluboké vodě nejsou efektivní a jejich šetrné provedení je technicky téměř nemožné.

● Podložení ramen a pánve

Opatrně se přiblížíme k tonoucímu, snížíme se rameny na jeho úroveň, opatrně vsuneme obě paže pod

ramena a pánev postiženého (dlaň pod pánví směřuje dolů), s tonoucím se rozejdeme a širokými úkroky se pohybujeme vpřed tak, aby se dolní končetiny dostaly do splývavé polohy a jedné roviny s páteří – tzv. in-line polohy. Je to nejjednodušší technika, která splní svůj účel, pokud je správně provedena.

- **Dlaha hlavy pažemi**

Technicky náročnější varianta. Tonoucího svými dlaněmi palcem nahoru uchopíme uprostřed jeho paží a pomalu ve vodě povedeme ruce do úplného vzpažení. Tlakem paží v úrovni uší docílíme tzv. dlahy hlavy, opět se snížíme rameny na úroveň vodní hladiny a opatrně přehmátneme. Pokud si touto technikou nejsme jisti, provádíme podložení ramen a pánve. Tuto techniku ale musíme použít, pokud je tonoucí obličejem do vody a je nutné jej primárně otočit.

3. Dušení např. jídlem

Příznaky

Osoba, která má částečnou obstrukci dýchacích cest:

- bude schopna částečně dýchat, ale bude to znít jinak než obvykle, protože vzduch prochází užším prostorem,
- bude schopna kašlat, případně i plakat,
- obvykle bude schopna vlastními silami odstranit ucpání hrdla

Osoba, která má úplnou obstrukci dýchacích cest:

- nebude schopna dýchat, kašlat ani plakat,
- bude potřebovat pomoc-bez ní brzy ztratí vědomí

První pomoc u dušení

Pokud má osoba částečnou obstrukci, měli byste ji v první řadě povzbudit, aby zakašlala a pokusila se odstranit blokádu a předmět vyplivla z úst.

Nevkládejte jí prsty do úst, protože by vás mohla pokousat nebo byste mohli zatlačit překážku dále do krku. Pokud tyto kroky nefungují, bude nutné přistoupit na použití úderu otevřenou dlaní do horní části zad (Gordonův manévr).

Pokud má osoba úplnou obstrukci, měli byste začít pěti ranami do zad (Gordonův manévr). Pokud rány do zad překážky úspěšně neodstraní, měli byste přejít k podání pěti břišních tahů (Heimlichův manévr). Břišní tahy by neměly být podávány dětem mladším jednoho roku nebo těhotným ženám. Pokud žádné údery do zad nebo nápory břicha překážku neodstraní, okamžitě volejte rychlou záchrannou službu 155. Pokračujte v cyklech, dokud nepřijde pomoc, a vždy se řiďte radami poskytnutými operátorem na lince záchranné služby.

Gordonův manévr u dospělých osob a dětí starších 1 roku

- V případě, že dusící se osoba přestane kašlat a začne sípat, pomozte ji vstát a předklonit se. V předklonu ji pětkrát udeřte do zad mezi lopatky.
- Zkontrolujte, zda se překážka v hrdle osoby uvolnila či nikoliv.
- Pokud dušení přetrvává, přejděte k Heimlichovo manévru, který popisujeme níže.

Heimlichův manévr u dospělých osob a dětí starších 1 roku

- Pokud nepomáhá Gordonův manévr, zahajte Heimlichův manévr (stlačení hrudníku a pupku).
- Postavte se za osobu, jednu ruku sevřete v pěst a přiložte ji mezi dolní konec hrudníku a pupek.
- Pokud to provádíte na menším dítěti, místo stání si za něj klekněte.
- Druhou rukou obejměte osobu, uchopte pěst druhé ruky a předkloňte se.
- Po předklonění pětkrát silně stlačte dovnitř a směrem nahoru.
- Zkontrolujte, zda se překážka neuvolnila či nikoliv.
- Pokud je překážka stále zablokovaná, okamžitě volejte rychlou záchrannou službu 155 a řiďte se radami operátora.

Resuscitace dítěte

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DÍTĚTE



Nehrozí nebezpečí? Volejte "Pomoc!"

Nereaguje?

DALŠÍ ZACHRÁNCE:

- Zavolejte 155 nebo resuscitační tým (hlasitý odposlech)
- Přineste a použijte AED (pokud je dostupný)

Zprůchodněte dýchací cesty

Nedýchá
nebo nedýchá normálně

- Vyškolení zachránce použijí k ventilaci samorozpínací vak s kyslíkem (2 ruce na masce)
- Pokud nelze ventilovat, provádějte nepřerušovanou srdeční masáž; umělé dýchání zahajte co nejdříve

5 umělých vdechů

Pokud nejsou známky života

SAMOTNÝ ZACHRÁNCE:

- Zavolejte 155 nebo resuscitační tým (hlasitý odposlech)
- V případě náhlého spatřeného kolapsu přineste a použijte AED (pokud je dostupný)

15 stlačení hrudníku

2 vdechy
15 stlačení hrudníku
dále střídejte
15 stlačení : 2 vdechy

SITUACE OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

1. Zlomeniny

Příznaky

- Zavřená zlomenina – typickými příznaky zlomeniny jsou porucha funkce a bolest, která se zhoršuje při pohybu poraněnou končetinou, otok a modřina. V případě, kdy došlo k posunu kostí i změna tvaru končetiny nebo její nepřirozená poloha.
- Otevřená zlomenina – při poranění došlo k porušení kůže a tkání. Rána krvácí a mohou z ní trčet části kosti nebo úlomky.

První pomoc u zlomenin

1. S pacientem se snažte co nejméně hýbat, hlavně když se jedná o poranění páteře. Nejlepší je, když ho ošetříte na místě a vyčkáte příjezdu záchranné služby. V případě, kdy pacientovi hrozí další nebezpečí je naopak transport nutný.
2. Pokud se jedná o otevřenou zlomeninu, volejte neprodleně záchranou službu 155. Následně zastavte krvácení. Když z rány trčí kost, nesnažte se jí zastrčit zpátky dovnitř. Vhodné je použít celý obvaz nebo jiný obvazový materiál, pomocí kterého vyskládáte okolo trčící kosti ochrannou vrstvu (nejlépe do její výšky) a až pak začnete obvazovat. Obvaz tím

pádem nebude tlačit přímo na kost a nebude způsobovat další bolest. V případě, že se vám krvácení nedaří zastavit, použijte zaškrcovadlo.

3. Když se jedná o nekomplikovanou zlomeninu a osoba se dokáže pohybovat sama (např. při zavřené zlomenině ruky) můžeme jí do nemocnice transportovat sami, ale pouze se svolením rodičů.
4. V případě komplikované zlomeniny volejte neprodleně záchranou službu 155.
5. Do příjezdu záchranky kontrolujte vědomí a zabezpečte tepelný komfort.
6. Improvizovanou dlahu vytvářejte jen v případě, že pacienta musíte přenášet a končetinu nejde znehybnit jiným způsobem např. ruku si může zraněný držet tak, jak mu to vyhovuje a ulevuje od bolesti. Měli byste se držet pravidla, že dlaha se má přizpůsobit končetině, ne končetina dlaze. Když čekáte na záchranou službu je vytváření improvizované dlahy zbytečné, protože nasazování způsobuje bolest.

2. Poranění páteře

Příznaky

Typickými příznaky jsou bolesti zad při úraze, poruchy hybnosti (např. dolních končetin) nebo změna cití (mravenčení, brnění). Nad poraněním páteře přemýšlejte vždy, odpovídá-li tomu mechanismus úrazu.

První pomoc u poranění páteře

Cílem poskytnutí první pomoci při poranění páteře je minimalizovat pohyb pacienta s důrazem na zachování dechu.

1. Bezpečnost. Jako vždy, na prvním místě je vaše vlastní bezpečnost. Nejprve se přesvědčte, že vám nehrozí žádné nebezpečí.
2. I zde je prioritou zachování základních životních funkcí.
 - Dýchá normálně. V tom případě nechte pacienta v poloze, v jaké se nachází a pokud je při vědomí, poskytněte mu psychologickou první pomoc. Je nutné mu vysvětlit důležitost minimalizace dalšího pohybu.
 - Nedýchá normálně. Zabezpečení základních životních funkcí má přednost před minimalizací rizika poškození míchy. Pokud postižený nedýchá, je nutné jej šetrně otočit na

záda a zahájit resuscitaci dle platných postupů.

3. Neodkladně volejte záchrannou službu 155. Další ošetření, a hlavně transport pacienta nechte profesionálům. Přivolejte zdravotnickou záchrannou službu vytočením čísla 155.
4. Tepelný komfort. Do příjezdu záchranné služby zajistěte tepelný komfort pacienta. I když se to nezdá, poraněný pacient ztrácí teplo i v relativně pro vás příjemné teplotě.

3. Úraz hlavy

Příznaky

Pokud na hlavě vidíte krvácení, je to jasné. To se ale nemusí vždy objevit. Na úraz hlavy pomýšlejte i v případě působení velké energie (např. po pádu). Mezi další příznaky řadíme: nevolnost, zvracení, porucha vědomí až bezvědomí, zmatenost, bolest hlavy, ztráta paměti na událost, výtok krve z uší či nosu, modřiny připomínající brýle (tzv. brýlový hematoma), nestejná šířka zornice

Mnohé určitě napadne pojem „otřes mozku“ v souvislosti s úrazem hlavy. Dojde-li k velkému úderu či nárazu do hlavy mozek se „obouchá“ o svou kostěnou schránku, která slouží jako jeho ochrana. Tím dojde k jeho „otřesení“. Typickým příznakem je krátkodobé bezvědomí, výpadek paměti na

událost (pamatuje si vše před ní, jen prostě neví, co se stalo. A i když mu to řeknete, v zápětí se zeptá znovu). Dále nevolnost a zvracení.

První pomoc u úrazu hlavy

1. Bezpečnost. Stejně jako jindy, než začnete poskytovat první pomoc, zajistěte si vlastní bezpečnost. Sem řadíme i nasazení rukavic, je-li to možné.
2. Poloha. Pokud je zraněný při vědomí, je ideální poloha se zvýšenou horní polovinou těla. V případě, že je v bezvědomí je situace jiná a postupujeme jako u klasického bezvědomí.
3. Volání ZZS. Přivolejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. To není nutné u postižených s pouze malým poraněním hlavy bez poruchy vědomí nebo paměti na událost – v těchto případech postačí sledování postiženého zodpovědnou osobou.
4. Tepelný komfort. Zajistěte tepelný komfort pacienta. Přehodte přes něj svou mikinu, izolujte ho od studené země nebo použijte izotermickou fólii.
5. Zástava krvácení. Na hlavně se nesetkáte s masivním krvácením. Pouze pokud to čas dovolí, můžete krvácející rány překrýt.
6. Zdravotní stav pacientů s úrazem hlavy se může rychle změnit. Proto neodcházejte a sledujte jej. V případě jakékoliv změny pružně

reagujte. Může upadnout do bezvědomí či dokonce přestat dýchat a bude nutné zahájit resuscitaci.

4. Řezné rány

Příznaky

Hlavními symptomy řezných a bodných ran je krvácení (zejména u řezné rány) a bolestivost. Může se objevit infekce, která je nejpravděpodobnější u ran bodných, znečištěných a v případech, kdy rány nebyly okamžitě ošetřeny.

První pomoc u řezné rány:

Pokud rána silně krvácí, volejte zdravotní záchranou službu.

Drobné řezné a bodné rány můžete ošetřit sami. Před jakoukoliv manipulací s ránou si vždy řádně umyjte ruce vodou a mýdlem nebo antibakteriálním prostředkem, aby se zabránilo infekci.

U drobné řezné rány postupujte podle následujících kroků:

- Nejprve se snažte zabránit krvácení přiložením sterilního obvazu.
- Při silnějším krvácení přiložte tlakový obvaz. Pokud se krvácení nezastaví, navštivte lékaře. Zřejmě bude nutné ránu odborně ošetřit.

- Po zástavě krvácení je vhodné ránu omýt tekoucím proudem čisté vody.
- Okolí rány potřete nebo postříkejte dezinfekcí.
- Na ránu aplikujte sterilní krytí, které se nelepí k ráně.

U drobných bodných ran postupujte následovně:

- Promývejte ránu proudem vody po dobu nejméně 5 minut, pak umyjte mýdlem.
- Ránu řádně prohlédněte. Pokud v ráně zůstala cizí tělesa, nikdy je sami neodstraňujte, ale obvazem zajistěte proti posunutí, sterilně kryjte a vyhledejte lékařskou pomoc.
- V okolí rány aplikujte dezinfekci a na ránu sterilní krytí, které se nelepí k ráně.

5. Popáleniny

Příznaky

- 1. stupeň – nejčastěji způsobená sluníčkem nebo krátkodobým dotykem horkého předmětu. Typickým příznakem je zarudnutí a bolest, někdy i otok. Kůže je neporušena a většinou se popálenina hojí spontánně do několika dnů.
- 2. stupeň – závažnější popálení. Tvoří se puchýře, kůže je červená a citlivá. Mohou se tvořit jizvy.

- 3. stupeň – nejzávažnější poškození kůže. Paradoxně nebolí, protože došlo k poškození nervových zakončení. Kůže je bílá až šedobílá, zuhelnatělá. Vyžaduje si chirurgický zákrok. (Popáleniny)

Každá popálenina, která postihuje více než 15 % tělesného povrchu u dospělého a 10 % u dětí, je život ohrožující a je nutná hospitalizace.

První pomoc u popálenin

1. Zastavte působení tepla.
2. Pokud se jedná o hořící oděv, uhasťte ho nejlépe válením po zemi nebo pomocí pokrývky/kabátu. Hořící člověk má tendenci utíkat, tím však hoření jenom podporuje.
3. Při opaření je potřebné co nejrychleji sundat oděv (nesundáváme však pevně lnoucí části oděvu).
4. Chladte postižená místa.
5. Pokud se jedná o lokální popáleninu, chladte do úlevy od bolesti, nejlépe tekoucí vodou. Nezávažné, malé popáleniny 1. stupně si většinou nevyžadují lékařské ošetření a hojí se spontánně. Na takové popáleniny je možné aplikovat přípravky obsahující panthenol. Na překrytí je vhodné použít hydrofilní, antiseptické náplasti.

6. Při rozsáhlých popáleninách (nad 20 %) chladte jen jednorázově a krátkodobě.
7. Sejměte náramky, prsteny, náušnice.
8. S postiženými plochami manipulujte co nejméně. Každý nešetrný pohyb způsobuje bolest a zhoršuje stav.
9. Pokud se jedná o rozsáhlé popálení, volejte ZZS.
10. Kontrolujte stav vědomí do příjezdu sanitky.
11. V případě, že pacient nedýchá normálně, zahájíme resuscitaci.

6. Poranění oka

a) Cizí tělísko ve spojivkovém vaku

Spadlo mi něco do oka, vidíš to tam? To je věta, kterou jste asi každý slyšel už mockrát v životě. Drobná tělíska (řasa, smítko, drobný hmyz) ráda ulpívají ve spojivkovém vaku (pod víčkem), kde dráždí oko k slzení.

První pomoc

Vyzvěte dotyčného, aby si nemnul oko, uchopte palcem a ukazováčkem víčka, rozevřete je a prohlédněte prostor pod horním i dolním víčkem. Tělísko odstraňte čistým vlhčeným kapesníkem nebo gázovým čtvercem. Nikdy ovšem tvrdým předmětem.

Nikdy neodstraňujte zaseknutá tělíska! Pomoci mohou také oční výplachy.

a) Pronikající poranění

Tento typ poranění bývá často velmi závažný. Příkladem je zapíchnutá větvička v oku. Některá tělesa jsou jasně patrná na první pohled, jiných si všimnout vůbec nemusíte. Dotyčný bude pociťovat bolest, oko bude slzet a víčka se budou stahovat bolestí k sobě.

První pomoc

Viditelná tělesa nikdy nevyndávejte. I tělesa, která nevidíte, berte vážně, často dělají závažná poranění. Sterilně kryjte obě oči! Je nutné zamezit souhybům očí, aby nedošlo k dalšímu poranění. Dotyčnému poskytněte psychologickou podporu. Tato situace je pro postiženého velmi stresující. Okamžitě volejte 155.

7. Laryngitida

Příznaky

Laryngitida je akutní zánětlivé onemocnění, které je nejčastěji způsobené virem.

Většinou se onemocnění objevuje náhle v noci z plného zdraví nebo navazuje na prochlazení. Typickým příznakem je suchý dráždivý (štěkavý)

kašel. Dítě je neklidné, má zvýšenou teplotu a má hrubý hlas (chraptí). (Akutní laryngitida)

U malých dětí může mít laryngitida dramatický průběh. Když dojde k úplnému uzavření dýchacích cest, vzduch se nedostává do plic a dojde k udušení. V takovýchto případech dítě bývá dušné, sípe a může i promodrávat. Pokud se objeví tyto příznaky, je nutné přivolat záchranou službu 155.

První pomoc u laryngitidy

1. Volání ZZS. Přivolejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 a pečlivě popište příznaky. Zmiňte podezření na laryngitidu.
2. Zachovejte klid a nepanikařte. Vyhněte se tak zbytečným chybám.
3. Zvlhčete vzduch pomocí zvlhčovače nebo pomoci vlhkého ručníku/plachty, kterou vyvěste nad postýlku.
4. Na krk přiložte studený obklad.
5. Hlavu dítěte vypodložte polštářem, aby se mu lépe dýchalo.
6. Otevřete okno, aby dítě dýchalo studený vzduch. Když venku není zima, použijte jako náhradu studený vzduch z mrazáku.
7. Snažte se dítě co nejvíce upokojit. Při pláči se otok dýchacích cest zvýrazní a stav se zhorší.
8. Při zvýšené teplotě podejte léky na její snížení.

8. Epiglottitida

Příznaky

Epiglottitida je akutní zánět hrtanové příklopky a okolitého tkaniva.

Onemocnění začíná náhle a má rychlý průběh. Typické příznaky jsou řezavá bolest v krku, potíže s dechem a zvýšená teplota. Dítě bývá bledé a z úst mu vytékají sliny, které nemůže polknout. Může se objevit i lehký kašel. Zánět způsobuje otok hrtanové příklopky, která se několikrát zvětší, a tím hrozí uzavěření dýchacích cest. Jelikož onemocnění je akutní a hrozí udušení, je nutné co nejdříve zavolat záchranou službu 155.

První pomoc u epiglottitidy

1. Volání ZZS. Přivolejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 a pečlivě popište příznaky. Zmiňte podezření na Epiglottitidu.
2. I v této situaci je nutné zachovat klid a rozvahu.
3. Dítě uložte do polosedu. Nikdy ho neukládajte do vodorovné polohy na záda. Oteklá příklopka by uzavřela dýchací cesty a došlo by k udušení.
4. Pokuste se dítě uklidnit.

Zdroje

<https://www.resuscitace.cz/>

<https://www.prpom.cz/>

<https://is.muni.cz/>